BONUS 1

Voordat je je supervisor belt: voorbereiding in 25 situaties

Zie voor 25 dienstsituaties één voor één welke beelden open moeten staan, welke vensters klaar moeten staan, welke gegevens je voor je moet hebben en met welke zin je het gesprek begint, nog voordat je de telefoon pakt.

Inhoud

Hoe je goed belt: SBAR

Algemene checklist vóór elk telefoontje

Deel 1 · Neurosituaties (1–6)

Deel 2 · Thorax- en vaatsituaties (7–10)

Deel 3 · Abdomen- en bekkensituaties (11–17)

Deel 4 · Trauma- en wervelkolomsituaties (18–21)

Deel 5 · Veiligheids-, protocol- en verslagsituaties (22–25)

Na het telefoontje

Volgende stap

AAN DE SLAG

Hoe je goed belt: SBAR

Een gestructureerd gesprek, zodat je supervisor de situatie in de eerste paar zinnen begrijpt.

> *De eerste vraag van een radioloog die midden in de nacht wordt gebeld, is altijd dezelfde: «Wat heb je gezien en wat wil je van me?» SBAR beantwoordt die twee vragen nog voordat ze gesteld worden.*

LETTER	BETEKENIS	WAT JE ZEGT
S	Situatie (Situation)	Wie je bent, welke patiënt, welk onderzoek, waarom je belt: één zin.
B	Achtergrond (Background)	Klinische vraag, relevante voorgeschiedenis, lab, eerder onderzoek.
A	Beoordeling (Assessment)	Wat je ziet, waar, en wat je denkt.
R	Advies / verzoek (Recommendation)	Wat je van je supervisor wilt: naar de beelden kijken, een protocolbeslissing, goedkeuring van het verslag, langskomen.

Sjabloon voor de openingszin

«Hoi, met [je naam], de dienstdoende AIOS. Ik beoordeel [onderzoek] van een patiënt ([leeftijd/geslacht]) van [afdeling]. Er is een aspect dat doet denken aan [bevinding] en ik bel voor [je verzoek].»

Stel het telefoontje niet uit

De voorbereidingslijsten zijn er om het telefoontje beter te maken, niet om het uit te stellen. Is de patiënt instabiel of zie je een levensbedreigende bevinding, bel dan eerst; wat ontbreekt vul je aan tijdens het gesprek.

ELKE KEER

Algemene checklist vóór elk telefoontje

De basisvoorbereiding die in alle 25 situaties geldt.

Voordat je de telefoon pakt

- [ ] Ik heb de identiteit van de patiënt en de koppeling van het onderzoek aan de juiste patiënt met twee identificatoren gecontroleerd.
- [ ] Naam, datum, tijdstip en protocol (met / zonder contrast, fasen) van het onderzoek liggen voor me.
- [ ] De relevante beelden staan open in PACS; de coupe waarop de bevinding het best zichtbaar is gemarkeerd.
- [ ] Het benodigde venster of de benodigde sequentie staat klaar.
- [ ] Ik heb gekeken of er eerder onderzoek is; zo ja, dan staat het ernaast open.
- [ ] De klinische vraag en de anamnese van het aanvraagformulier liggen voor me.
- [ ] Ik heb de relevante labuitslagen bekeken.
- [ ] Ik ken de huidige klinische toestand van de patiënt (stabiel / instabiel, waar).
- [ ] Ik kan in één zin zeggen wat ik van mijn supervisor wil.
- [ ] Papier voor aantekeningen of een conceptverslag geopend.

DEEL 1

Neurosituaties

Situatie 1–6 · Bloeding, beroerte, intracraniële druk en spinale compressie.

Situatie 01 NEURO

Verdenking op subarachnoïdale bloeding

ZORG DAT KLAARSTAAT

- Blanco CT-hersenen; hersenvenster en smal (CVA-)venster.
- Basale cisternen, fissurae Sylvii en occipitale hoorns gemarkeerd.
- Ventrikelgrootte en temporale hoorns: hydrocefalie aanwezig/afwezig.
- Tijdstip van begin van de symptomen, bewustzijn, gebruik van antistolling.
- Eerder hersenonderzoek, indien beschikbaar.

OPENINGSZIN

> *«Hoi, op de blanco CT-hersenen van een SEH-patiënt met acuut ontstane, hevige hoofdpijn zie ik in de basale cisternen een hyperdensiteit die past bij een subarachnoïdale bloeding. Hydrocefalie [aanwezig/afwezig]. Ik wil graag dat je naar de beelden kijkt en de beslissing over CT-angiografie bespreken.»*

Situatie 02 NEURO

Code CVA

ZORG DAT KLAARSTAAT

- Blanco CT en smal CVA-venster; beoordeling op bloeding afgerond.
- Hyperdense arterie en gebieden van vroege ischemie gemarkeerd.
- Als er een CTA of perfusie is gemaakt: geopend en de volgende series klaargezet.
- Tijdstip van begin van de symptomen of laatst normaal gezien.
- Neurologisch beeld (welke zijde, welk deficit), gebruik van antistolling.

OPENINGSZIN

> *«Hoi, code CVA-patiënt; begin van de symptomen [tijdstip]. Op de blanco CT zag ik geen bloeding. Er is een hyperdense arterie in de ACM [zijde] en verdenking op vroege ischemie in [regio]. Ik wil de CTA graag samen met je beoordelen.»*

Situatie 03 NEURO

Intracraniële bloeding bij een patiënt die antistolling gebruikt

ZORG DAT KLAARSTAAT

- Hersen-, subduraal (breed) en botvenster.
- Locatie van het hematoom, afmetingen in drie richtingen, dikste punt.
- Meting van de middellijnverschuiving, basale cisternen, uitbreiding naar de ventrikels.
- Type anticoagulans of plaatjesremmer, stollingstests, traumavoorgeschiedenis.
- Vergelijking met eerder onderzoek, indien beschikbaar.

OPENINGSZIN

> *«Hoi, op de CT-hersenen van een [leeftijd]-jarige patiënt die antistolling gebruikt, zie ik een acute bloeding in [locatie]; middellijnverschuiving [ja/nee]. Ik heb de clinicus ingelicht. Ik wil de metingen en de tekenen van herniatie graag samen met je doornemen.»*

Situatie 04 NEURO

Ik verdenk een isodens subduraal hematoom, maar weet het niet zeker

ZORG DAT KLAARSTAAT

- De convexiteiten in breed venster; het aspect van de sulci van beide zijden naast elkaar.
- Indirecte tekenen: verstreken sulci, compressie van de ventrikels, naar binnen verplaatste grijze-wittestofovergang.
- Coronale reconstructie geopend, indien beschikbaar.
- Duur van de symptomen en valanamnese.
- Eerder onderzoek.

OPENINGSZIN

> *«Hoi, op de CT van een oudere patiënt die met verwardheid binnenkwam, zijn de sulci over de convexiteit [zijde] verstreken; ik verdenk een isodens subduraal hematoom, maar ik weet het niet zeker. Ik wil graag dat je naar de beelden kijkt; zo nodig bespreken we een advies voor aanvullend onderzoek.»*

Situatie 05 NEURO

Tekenen van herniatie of acute hydrocefalie

ZORG DAT KLAARSTAAT

- Coupes waarop de suprasellaire cisterne, de perimesencefale cisternen en het niveau van de tonsillen zichtbaar zijn.
- Meting van de middellijnverschuiving.
- Ventrikelgrootte en vergelijking met eerder onderzoek.
- Oorzaak: bloeding, massa, infarct, shunt.
- Bewustzijn van de patiënt en waar hij zich bevindt.

OPENINGSZIN

> *«Hoi, op de CT van de patiënt van [afdeling] zie ik tekenen van [subfalciene / uncale] herniatie door [oorzaak] en [hydrocefalie]. Ik heb de clinicus ingelicht; ik wil de beelden graag direct samen met je beoordelen.»*

Situatie 06

NEURO · WERVELKOLOM

MRI-aanvraag bij verdenking op ruggenmergcompressie of caudasyndroom

ZORG DAT KLAARSTAAT

- Klinische informatie op de aanvraag: deficit, niveau, mictie- en defecatiefunctie, voorgeschiedenis van maligniteit of infectie.
- Is het MRI-veiligheidsformulier compleet (implantaat, pacemaker)?
- Eerdere beeldvorming van de wervelkolom, indien beschikbaar.
- Als het beoordeeld wordt: sagittale T2 en T1, compressieniveau gemarkeerd, axiale coupes klaar.
- Je vraag of een serie met contrast nodig is.

OPENINGSZIN

> *«Hoi, bij een patiënt die zich presenteert met [klinisch beeld] is een spoed-MRI aangevraagd bij verdenking op ruggenmergcompressie. Ik wil graag je akkoord voor het protocol: [regio / hele wervelkolom] en een serie met contrast.» Na de beoordeling: «Ik zie ruggenmergcompressie op [niveau] door [oorzaak].»*

DEEL 2

Thorax- en vaatsituaties

Situatie 7–10 · Embolie, aorta, pneumothorax, lijnen en drains.

Situatie 07 THORAX

Longembolie en rechterhartbelasting

ZORG DAT KLAARSTAAT

- CT-pulmonalisangiografie; mediastinumvenster, meest proximale locatie van de embolie gemarkeerd.
- Kwaliteit van het contrast beoordeeld.
- Verhouding rechterventrikel / linkerventrikel, septum, contrastreflux.
- Vitale parameters van de patiënt, zuurstofbehoefte.
- Aanvullende bevindingen in het longvenster.

OPENINGSZIN

> *«Hoi, op de CT-pulmonalisangiografie van de patiënt van [afdeling] zie ik een longembolie op [niveau] en tekenen van rechterhartbelasting. Ik heb de clinicus ingelicht. Ik wil de tekenen van belasting graag samen met je bevestigen.»*

Situatie 08 VATEN

Acuut aortasyndroom

ZORG DAT KLAARSTAAT

- Blanco serie en arteriële fase; sagittaal-oblique en coronale reconstructies.
- Waar de flap begint en eindigt, betrokkenheid van de aorta ascendens.
- Uit welk lumen de zijtakken worden gevoed.
- Pericardvocht, mediastinaal hematoom, orgaanperfusie.
- Bloeddruk, polsen, neurologisch beeld.

OPENINGSZIN

> *«Hoi, op de CT-aortografie van een SEH-patiënt met pijn op de borst zie ik een aortadissectie; betrokkenheid van de aorta ascendens [ja/nee]. Ik heb de clinicus ingelicht. Ik wil de uitbreiding en de zijtakken graag samen met je beoordelen.»*

Situatie 09

THORAX

Pneumothorax en verdenking op spanningspneumothorax

ZORG DAT KLAARSTAAT

- Röntgenfoto of CT; het gebied waar de pleuralijn zichtbaar is uitvergroot.
- Mediastinale verschuiving, positie van het diafragma.
- Ligt de patiënt aan de beademing, heeft hij een thoraxdrain, is het na een ingreep?
- Eerdere röntgenfoto.

OPENINGSZIN

> *«Hoi, op de röntgenfoto van de patiënt van [afdeling] zie ik een pneumothorax [zijde] en verschuiving van het mediastinum naar de andere kant. Ik heb de clinicus direct gebeld. Ik wil graag dat je naar de beelden kijkt.»*

Situatie 10

THORAX

Malpositie van tube of katheter

ZORG DAT KLAARSTAAT

- Beeld dat het hele verloop van het device toont; positie van de tip uitvergroot.
- Type device en tijdstip van plaatsing.
- Vergelijking met de eerdere röntgenfoto.
- Pneumothorax aanwezig/afwezig.

OPENINGSZIN

> *«Hoi, op de controlefoto van een IC-patiënt ligt de neusmaagsonde [in de bronchiaalboom / op een onverwachte plek]. Ik heb de clinicus ingelicht en geadviseerd de sonde opnieuw te beoordelen voordat hij gebruikt wordt. Ik wil graag dat je het verslag goedkeurt.»*

DEEL 3

Abdomen- en bekkensituaties

Situatie 11–17 · Vrije lucht, ischemie, AAA, obstructie, bloeding, torsie, extra-uteriene zwangerschap.

Situatie 11 ABDOMEN

Vrije lucht

ZORG DAT KLAARSTAAT

- Het hele abdomen in longvenster; de coupe met de meeste lucht gemarkeerd.
- Mogelijke bron: wanddefect, verdikking, infiltratie.
- Recente chirurgie of interventie? (om postoperatieve lucht te onderscheiden)
- Vrij vocht, collectie.
- Kliniek: koorts, défense musculaire, lab.

OPENINGSZIN

> *«Hoi, op de CT van een patiënt met een acute buik zie ik vrije lucht in [locatie]; als bron denk ik aan [segment]. Recente chirurgie in de voorgeschiedenis: [nee/ja]. Ik heb de clinicus ingelicht; ik wil de bron graag samen met je beoordelen.»*

Situatie 12 ABDOMEN

Verdenking op mesenteriale ischemie

ZORG DAT KLAARSTAAT

- Arteriële en portaal-veneuze fase; sagittale reconstructie langs de AMS en de VMS.
- Niet-aankleurende of oedemateuze darmsegmenten gemarkeerd.
- Pneumatosis en portaal-veneus gas (longvenster).
- Ritmestoornis, lactaat en ander relevant lab.

OPENINGSZIN

> *«Hoi, op de CT-angiografie van een oudere patiënt met hevige buikpijn zie ik een vullingsdefect in de AMS op [niveau] en verlies van aankleuring in [segment]. Ik denk aan mesenteriale ischemie en heb de clinicus ingelicht. Ik wil graag dat je er direct naar kijkt.»*

Situatie 13

VATEN

Geruptureerd of symptomatisch AAA

ZORG DAT KLAARSTAAT

- Meting van de maximale diameter (buitenwand tot buitenwand), uitbreiding.
- Beelden van het retroperitoneale hematoom en de extravasatie.
- Relatie met de nierarteriën en de iliacale arteriën.
- Bloeddruk, hemoglobine; is er een aneurysma bekend van eerder onderzoek?

OPENINGSZIN

> *«Hoi, op de CT van een patiënt met rugpijn en hypotensie zie ik een abdominaal aorta-aneurysma en een retroperitoneaal hematoom; ik denk aan een ruptuur. Ik heb de clinicus ingelicht. Ik wil de metingen en de extravasatie graag samen met je beoordelen.»*

Situatie 14

ABDOMEN

Verdenking op closed-loop-obstructie of strangulatie

ZORG DAT KLAARSTAAT

- Het transitiepunt (of twee transitiepunten) gemarkeerd; coronale reconstructie geopend.
- Whirl in het mesenterium, oedeem, vocht.
- Wandaankleuring: vergelijking van de aangedane lis met een normale lis.
- Eerdere chirurgie, voorgeschiedenis van een hernia.

OPENINGSZIN

> *«Hoi, op de CT van een patiënt met een ileusbeeld zie ik in [locatie] een aspect dat aan een closed loop doet denken en een verminderde wandaankleuring. Ik verdenk strangulatie. Ik wil graag dat je naar de beelden kijkt.»*

Situatie 15

ABDOMEN · VATEN

Actieve gastro-intestinale bloeding: CT-angiografie

ZORG DAT KLAARSTAAT

- Blanco, arteriële en portaal-veneuze fase naast elkaar; hetzelfde coupeniveau gesynchroniseerd.
- Coupes waarop de extravasatie in de arteriële fase zichtbaar is en in de veneuze fase groter wordt.
- Mogelijk voedend vat.
- Hemoglobine, transfusie, uitslag van de endoscopie.

OPENINGSZIN

> *«Hoi, op de CT-angiografie van de patiënt met een GI-bloeding zie ik in [segment] actieve extravasatie die in de arteriële fase verschijnt en in de veneuze fase groter wordt. Mogelijk is interventionele behandeling nodig; ik wil het graag samen met je beoordelen.»*

Situatie 16

SCROTUM · BEKKEN

Verdenking op testis- of ovariumtorsie

ZORG DAT KLAARSTAAT

- Vergelijkende opnames van beide zijden met dezelfde Doppler-instellingen.
- Grootte, echogeniciteit, beeld van het whirlpool sign.
- Tijdstip waarop de pijn begon.
- Voor het ovarium: uitslag van de zwangerschapstest, bekende cyste of massa.

OPENINGSZIN

> *«Hoi, bij een patiënt met acute pijn die [duur] geleden begon, toont de Doppler-echo van [testis / ovarium] [zijde] een duidelijk verminderde flow en een whirlpool-aspect. Ik denk aan torsie en heb de clinicus ingelicht. Ik wil de beelden graag samen met je beoordelen.»*

Situatie 17

ZWANGERSCHAP

Extra-uteriene zwangerschap en hemoperitoneum

ZORG DAT KLAARSTAAT

- Opnames van de uterus (vruchtzak wel/niet aanwezig), de adnexen en het cavum Douglasi.
- Beeld van de pouch van Morison.
- Zwangerschapstest en relevant lab, datum van de laatste menstruatie.
- Hemodynamische toestand van de patiënt.

OPENINGSZIN

> *«Hoi, op de echo van een patiënte met een positieve zwangerschapstest en bekkenpijn zie ik geen intra-uteriene vruchtzak; in de adnexen [zijde] is een massa en echogeen vrij vocht. Ik heb de clinicus en de gynaecologie ingelicht. Ik wil de beelden graag samen met je beoordelen.»*

DEEL 4

Trauma- en wervelkolomsituaties

Situatie 18–21 · Total-body CT, cervicale wervelkolom, solide organen, bekken.

Situatie 18

TRAUMA

Total-body CT: eerste beoordeling en voorlopige melding

ZORG DAT KLAARSTAAT

- Lijst van levensbedreigende bevindingen (intracraniële bloeding, pneumothorax, aorta, actieve bloeding).
- De coupe waarop elke bevinding het best zichtbaar is gemarkeerd.
- Traumamechanisme, hemodynamiek, uitgevoerde interventies.
- Lijst van gebieden die je nog niet hebt bekeken.

OPENINGSZIN

> *«Hoi, bij een patiënt met een total-body CT na een verkeersongeval zie ik bij mijn eerste beoordeling [bevinding 1] en [bevinding 2]. Ik heb het traumateam een voorlopige melding gedaan. Ik ga verder met de gedetailleerde beoordeling; ik wil de prioritaire bevindingen graag samen met je bevestigen.»*

Situatie 19

TRAUMA · WERVELKOLOM

Fractuur of standsafwijking van de cervicale wervelkolom

ZORG DAT KLAARSTAAT

- Sagittale en coronale reconstructies; botvenster.
- Niveau van de fractuur, stand van de facetten, wervelkanaal.
- Is het foramen transversarium betrokken?
- Bevindingen van het neurologisch onderzoek.

OPENINGSZIN

> *«Hoi, op de cervicale CT van een traumapatiënt met een halskraag zie ik [een fractuur / een facetluxatie] op [niveau]; het foramen transversarium is [wel / niet] betrokken. Ik heb de clinicus gezegd dat de halskraag moet blijven zitten. Ik wil de noodzaak van MRI en CTA graag bespreken.»*

Situatie 20

TRAUMA · ABDOMEN

Actieve extravasatie bij letsel van een solide orgaan

ZORG DAT KLAARSTAAT

- Arteriële en portaal-veneuze fase naast elkaar.
- Uitgebreidheid van de laceratie en betrokkenheid van de hilus.
- Hoeveelheid hemoperitoneum en locatie van het dichtste stolsel.
- Gegevens over hemodynamiek en transfusie.

OPENINGSZIN

> *«Hoi, op de CT van een patiënt met stomp trauma zie ik een laceratie van [orgaan] en actieve arteriële extravasatie; hemoperitoneum [gering/matig/uitgebreid]. Ik heb het traumateam ingelicht. Ik wil het graag samen met je beoordelen met het oog op interventionele behandeling.»*

Situatie 21

TRAUMA · BEKKEN

Bekkenfractuur en bekkenbloeding

ZORG DAT KLAARSTAAT

- Fracturen van de voorste en achterste ring, sacro-iliacale gewrichten, symfyse.
- Beelden van het bekkenhematoom en de extravasatie.
- Bevindingen aan blaas en urethra.
- Is er een bekkenband aangelegd, hemodynamiek.

OPENINGSZIN

> *«Hoi, bij een traumapatiënt met een bekkenband zie ik [fracturen] en actieve extravasatie in een bekkenhematoom. Ik heb het traumateam ingelicht. Ik wil graag dat je het direct beoordeelt met het oog op interventieradiologie.»*

HOOFDSTUK 5

Veiligheids-, protocol- en verslagsituaties

Situatie 22–25 · Contrastreactie, MRI-veiligheid, juistheid van de aanvraag, correctie van het verslag.

Situatie 22

VEILIGHEID

Contrastreactie

ZORG DAT KLAARSTAAT

- Blijf eerst bij de patiënt en roep volgens protocol het spoedteam van je instelling op; bel daarna pas.
- Type contrastmiddel en tijdstip van toediening.
- Symptomen en tijdstip van ontstaan, vitale parameters.
- Bekende allergie in de voorgeschiedenis.

OPENINGSZIN

> *«Hoi, een patiënt die tijdens [onderzoek] jodiumhoudend contrast kreeg, heeft [symptomen] ontwikkeld. We zijn gestopt met de injectie en hebben het spoedteam opgeroepen; de patiënt is nu [toestand]. Even ter informatie; ik wil graag dat je komt / me aanwijzingen geeft.»*

Situatie 23

VEILIGHEID

Vraag over implantaat of metaal vóór MRI

ZORG DAT KLAARSTAAT

- Ingevuld MRI-veiligheidsformulier.
- Type implantaat, datum van plaatsing, implantaatkaart of documentatie indien beschikbaar.
- Eerdere röntgenfoto of CT waarop het implantaat te zien is, indien beschikbaar.
- Urgentie van het onderzoek en alternatieve onderzoeksopties.

OPENINGSZIN

> *«Hoi, de patiënt voor wie een spoed-MRI is aangevraagd heeft [implantaat]; een MRI-compatibiliteitsdocument is [wel/niet] aanwezig. Ik heb de patiënt niet de ruimte in genomen. Ik wil graag samen beslissen of het onderzoek kan doorgaan en wat het alternatief is.»*

Situatie 24

PROTOCOL

Aanvraag en klinische vraag komen niet overeen of het protocol is onduidelijk

ZORG DAT KLAARSTAAT

- Het aanvraagformulier en de aanvullende klinische informatie die je van de clinicus kreeg.
- Het aangevraagde onderzoek, het alternatief dat jij voorstelt en de reden daarvoor.
- Benodigde gegevens voor contrast (nierfunctie, allergie, zwangerschap).
- Protocollijst van de instelling.

OPENINGSZIN

> *«Hoi, vanuit de SEH is [onderzoek] aangevraagd voor [klinische vraag]. Op basis van de klinische gegevens denk ik dat [alternatief] geschikter kan zijn, omdat [reden]. Ik wil de protocolbeslissing graag met je bevestigen.»*

Situatie 25

VERSLAG

Belangrijke bevinding gemist in een eerder verslag of bij de voorlopige beoordeling

ZORG DAT KLAARSTAAT

- Het betreffende verslag of de voorlopige beoordeling en het tijdstip van verzending.
- Het beeld van de gemiste bevinding gemarkeerd.
- De huidige toestand van de patiënt en waar hij is.
- Conceptzin voor het gecorrigeerde verslag.

OPENINGSZIN

> *«Hoi, bij het opnieuw bekijken van [onderzoek], waarvan ik om [tijdstip] de voorlopige beoordeling heb doorgegeven, zag ik [bevinding]. Dat kan klinisch belangrijk zijn. Voordat ik de clinicus inlicht, wil ik het met je bevestigen en je aanwijzingen voor een addendum bij het verslag.»*

AFSLUITING

Na het telefoontje

Wat niet op papier komt, gaat verloren.

Nadat je hebt opgehangen

- [ ] Ik heb het advies en het besluit van mijn supervisor in mijn eigen woorden herhaald en bevestigd.
- [ ] Ik heb de clinicus ingelicht; ik heb vastgelegd aan wie en hoe laat.
- [ ] Ik heb het verslag volgens de aanwijzingen van mijn supervisor afgerond of gecorrigeerd.
- [ ] Als er aanvullend onderzoek werd geadviseerd, heb ik dat doorgegeven aan het aanvragende team.
- [ ] Wat ik heb geleerd, heb ik na de dienst in mijn foutenlogboek genoteerd.

Slotzin

«Als ik het goed begrijp: [besluit]. Ik geef het aan de clinicus door als [boodschap] en schrijf het verslag daarop aan. Wil je nog iets toevoegen?»

Uitsluitend voor educatieve doeleinden. Dit materiaal vervangt de opleiding, supervisie, het klinisch oordeel of het verslag van een specialist niet.

Volgende stap

Je bent klaar om te bellen. Focus nu op het niet missen van de bevinding die het telefoontje vereist.

«De 40 vaakst gemiste bevindingen tijdens de dienst» Open het bestand (Bonus 2): zie waar de vaakst gemiste bevindingen zich verstoppen en met welk venster ze zichtbaar worden.